MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO ECLAMPSIA

PASV

Nombre_____**Identificación**_____**Edad**_____

Hospital_____**Ciudad**_____**Departamento**_____

Diagnóstico

Definición: convulsión o coma superpuesto a paciente con pre-eclampsia

Pasos a seguir

Atención INMEDIATA

- ☐ Alertar al equipo de trabajo, **PEDIR AYUDA**
- ☐ Desginar al Líder del equipo
- ☐ Designar una función a cada integrante del equipo
- ☐ Asegurar barandas de la cama
- ☐ Iniciar monitorización continua de signos vitales no invasiva
  - Saturación de oxígeno <90%, tomar radiografía de tórax
- ☐ Iniciar monitorización fetal continua
- ☐ Realizar ABCD
- ☐ Asegurar dos accesos venosos 16G o 18G en el mismo brazo
- ☐ Obtener línea arterial para monitoría invasiva de tensión arterial
- ☐ Tomar paraclínicos para definir severidad: hemograma, ALT, AST, LDH y creatinina
- ☐ Posicionar en decúbito lateral a la paciente
- ☐ Proteger la vía aérea y mejorar la oxígenación
- ☐ Iniciar oxígeno suplementario con mascara de no reinhalacipon a 10L/min FiO2 85%
- ☐ Definir si requiere intubación: convulsiones persistentes --> ingreso a UCI
- ☐ • Tener disponibilidad de ventilación con bolsa máscara
- ☐ • Tener disponibilidad de succión
- ☐ Iniciar manejo farmacológico de crisis hipertensiva si esta indicado
- ☐ • Iniciar manejo para eclampsia con Sulfato de Magnesio
- ☐ • Iniciar antihipertensivos en los primeros 15 minutos
- ☐ • Iniciar esteroides para maduración pulmonar, si esta indicado
- ☐ • Si hay edema pulmonar iniciar Nitroglicerina o nitroprusiato + Furosemida
- ☐ Iniciar control de líquidos administrados y eliminados.
- ☐ Definir neuroimágen si no hay alertamiento completo, estatus convulsivo o convulsiones atípicas
- ☐ Definir finalización del embarazo, por condición clínica y estabilidad hemodinámica
- ☐ Ingresar a UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
- ☐ Hablar con la paciente, la familia y el equipo obstétrico.

Antihipertensivo de mantenimiento

- **NIFEDIPINO:** Administrar una tableta de 30 mg cada 8 horas, o como alternativa:
- **METOPROLOL:** Administrar una tableta de 50 mg cada 6-8horas

Manejo del edema pulmonar

- **FUROSEMIDA:** Adminisitrar 40 mg vía intravenosa
- **NITROGLICERINA:** Adminisitrar 0.5mg/hora. Dosis máxima 4 mg/hora

HOSPITAL PADRINO

Sulfato de magnesio: manejo de eclampsia

☐ **DOSIS DE CARGA: 4 gramos de carga**

- Diluir 2 ampollas en 100 cc para pasar en bomba de infusión a 400 cc por hora. Si no hay bomba de infusión, pasar mezcla en 15 minutos en buretrol

☐ **Dosis de mantenimiento**

- Diluir 4 ampollas en 500cc y pasar a 67 cc por hora en bomba de infusión. Si no hay bomba pasar en macrogotero a 10 gotas por minuto

NUEVO EPISODIO CONVULSIVO EN PRESENCIA DE SULFATO DE MAGNESIO

Asegurar control adecuado de la tensión arterial

Episodio convulsivo activo: Adminisitrar 1 ampolla diluida en 10 cc de SSN, pasar en 3 minutos por vía intravenosa en bolo.

Episodio controlado: Administrar 4 gramos diluidos en 100 mL de SSN para pasar en bomba de infusión en 15 minutos.

Continuar con dosis de mantenimiento.

Antihipertensivos de primera línea

Meta tensión arterial TAS <150 TAD 90-100

☐ **1. Nifedipino**

Adminisitrar una tabletas de 10 mg (dosis inicial de 10 mg)

Repetir dosis de dos tabletas de 10 mg (20 mg) cada 20 minutos hasta lograr control de la tensión arterial

Dosis máxima 50- 60 mg.

Hora dosis 10 mg_____20 mg _____ 20 mg_____

SI COMPLETADAS LAS 3 DOSIS DE NIFEDIPINO (50 MG) NO HAY CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL INICIAR LABETALOL

☐ **2. Labetalol**

Adminisitrar bolos por vía intravenosa cada 20 minutos en dosis de 20-40-80-80-80mg

Monitorizar tensión arterial, parar infusión de bolos al lograr meta de tensión arterial

Máximo 300 mg de Labetalol en 24 horas.

Hora dosis 20mg_____40mg_____80mg_____80mg_____80mg_____

SI COMPLETADAS LAS 3 PRIMERAS DOSIS DE LABETALOL (140MG) NO HAY CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL INICIAR NITROPRUSIATO

☐ **3. Nitroprusiato**

Adminisitrar infusión intravenosa a dosis de 0.25mcg/kg/min (máximo 0.5mcg/kg/min)

Preparación: Diluir 1 ampolla de 50mg/2ml en 125 cc de DAD 5%,

Pasar en bomba de infusión. Goteo titulable hasta lograr metas de tensión arterial

Anticonvulsivante

Midazolam: 2 mg IV, repetir a los 10-25 minutos

Diazepam: 5-10 mg IV cada 5-10 minutos, máximo 30 mg

Lorazepam: 2-4 mg IV, repetir 10-15 minutos

Para pacientes con convulsiones recurrentes que han recibido 3 bolos de sulgato de magnesio o cuando este contraindicado

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO CRISIS HIPERTENSIVA

HOSPITAL

Nombre_____**Identificación**_____**Edad**_____

Hospital_____**Ciudad**_____**Departamento**_____

Diagnóstico

- Tensión arterial sistólica mayor o igual 160 mmHg y/o tensión arterial diastólica mayor a 110 mmHg.
- Síntomas de encefalopatía hipertensiva con tensiones arteriales menores a 160/110 mmHg, tales como vómito, náuseas, agitación y confusión.
- TA inicial _____ TA 15 min_____

Iniciar manejo en los primeros 15 minutos

Pasos a seguir

- ☐ Alertar al equipo de trabajo, PEDIR AYUDA
- ☐ Desginar al Líder del equipo
- ☐ Designar una función a cada integrante del equipo
- ☐ Asegurar barandas de la cama

C

Circulación

- ☐ • Dos acceso venosos 16G o 18G en el mismo brazo
- ☐ • Control de cifras tensionales cada 5 minutos
- ☐ • Monitoría fetal continua
- ☐ • Valor inicial TA _____ 5 min _____ 10 min _____ 15 min _____

R

Reducción de la presión arterial: iniciar manejo farmacológico

- ☐ • Iniciar **antihipertensivos** en los primeros 15 minutos desde el diagnóstico
- ☐ • Si hay edema pulmonar iniciar **Nitroglicerina o nitroprusiato + Furosemida**

I

- ☐ **Infusión** de sulfato de magnesio, profilaxis de eclampsia

S

Sostenimiento de la Tensión arterial

- ☐ • Iniciar Nifedipino dosis de 30 mg cada 8 horas
- ☐ • Definir finalización del embarazo, Inciar Esteroides maduración pulmonar
  - Paciente >34 ss con preeclampsia severa: finalización embarazo
  - Paciente <34 ss inductores de maduración pulmonar y definir finalización según condiciones clínicas maternas y fetales

I

- ☐ **Impacto** de órgano blanco: Toma de paraclínicos para definir severidad: Hemograma, AST, ALT, LDH, creatinina

S

- ☐ **Seguimiento:** Plan de manejo para cada paciente, definir manejo ambulatorio, control postparto y método de planificación
- ☐ Control de líquidos administrados y eliminados.
- ☐ Definir paso de sonda vesical
- ☐ Definir ingreso a unidad de alta dependencia o UCI intermedia (crisis hipertensiva)
- ☐ Definir ingreso a unidad de cuidados intensivos (urgencias hipertensiva)
- ☐ Hablar con la paciente, la familia y el equipo obstétrico.

Sulfato de magnesio: profilaxis eclampsia

DOSIS DE CARGA: 4 gramos de carga

- Diluir 2 ampollas en 100 cc para pasar en bomba de infusión a 400 cc por hora. Si no hay bomba de infusión, pasar mezcla en 15 minutos en buretrol

Dosis de mantenimiento

- Diluir 4 ampollas en 500cc y pasar a 67 cc por hora en bomba de infusión. Si no hay bomba pasar en macrogotero a 10 gotas por minuto

Antihipertensivos de primera línea

☐ **1. Nifedipino**

Adminisitrar una tableta de 10 mg (dosis inicial de 10 mg)
Repetir dosis de dos tabletas de 10 mg (20 mg) cada 20 minutos hasta lograr control de la tensión arterial
Dosis máxima 50- 60 mg.
Hora dosis 10 mg_____20 mg _____ 20 mg_____

Meta tensión arterial TAS <150 TAD 90-100

SI COMPLETADAS LAS 3 DOSIS DE NIFEDIPINO (50 MG) NO HAY CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL INICIAR LABETALOL

☐ **2. Labetalol**

Adminisitrar bolos por vía intravenosa cada 20 minutos en dosis de 20-40-80-80-80mg
Monitorizar tensión arterial, parar infusión de bolos al lograr meta de tensión arterial
Máximo 300 mg de Labetalol en 24 horas.
Hora dosis 20mg_____40mg_____80mg_____80mg_____80mg_____

SI COMPLETADAS LAS 3 PRIMERAS DOSIS DE LABETALOL (140MG) NO HAY CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL INICIAR NITROPRUSIATO

☐ **3. Nitroprusiato**

Adminisitrar infusión intravenosa a dosis de 0.25mcg/kg/min (máximo 0.5mcg/kg/min)
Preparación: Diluir 1 ampolla de 50mg/2ml en 125 cc de DAD 5%,
Pasar en bomba de infusión. Goteo titulable hasta lograr metas de tensión arterial

☐ **Antihipertensivo de mantenimiento**

- **NIFEDIPINO:** Administrar una tableta de 30 mg cada 8 horas, O alternativa:
- **METOPROLOL:** Administrar una tableta de 50 mg cada 6-8 horas.

☐ **Manejo del edema pulmonar**

- **FUROSEMIDA**: Admnistrar 40 mg vía intravenosa
- **NITROGLICERINA:** Administrar 0,5 mg/hora. Dosis máxima 4 mg/hora

PASV

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO SEPSIS MATERNA

HOSPITAL

Nombre_____**Identificación**_____**Edad**_____

Hospital_____**Ciudad**_____**Departamento**_____

Diagnóstico

- **Definición sepsis:** disfunción orgánica potencialmente mortal causada por respuesta incontrolable del huésped a la infección.
- **Definición de choque séptico:** sepsis con hipotensión persistente que requiere el uso de vasopresores para lograr una TAM mayor o igual a 65 mmHg y lactato mayor o igual a 2 mmol/L a pesar de un voluemn adecuado de resucitación

Paso 1:

1. Quick SOFA: Glasgow < 13 _____ TAS <100mmHg _____FR < 22 _____

(Con dos o más criterios positivos del Quick SOFA se considera sepsis)

2. Usar MEOWS siempre para valoración inicial de la paciente obstétrica (figura 1)

MEOWS Inicial_____

Paso 2: Calcular SOFA (figura 2)_____

Iniciar manejo 1° hora

Pasos a seguir

- ☐ Alertar al equipo de trabajo, PEDIR AYUDA
- ☐ Desginar al Líder del equipo
- ☐ Designar una función a cada integrante del equipo
- ☐ Asegurar barandas de la cama
- ☐ Monitoría no invasiva de signos vitales cada 2 minutos

A

- ☐ Asegurar vía aérea y monitorizar la tensión arterial y los signos vitales cada 2 minutos

B

- ☐ Administrar sumplemento de oxígeno con mascarilla con reservorio a 10 lt/min para asegurar la saturación de oígeno >95%
- ☐ Asegurar dos accesos venosos 16G o 18G y tomar muestras para laboratorio

C

- ☐ Administrar 20-30 ml/kg cristaloides en las primeras tres horas, guiarse por metas de TA
- ☐ Tomar 2 hemocultivos en brazos diferentes
- ☐ Iniciar tratamiento farmacológico
  - Antibióticoterapia
  - Norepinefrina : hasta alcanzar meta de TA

D

- ☐ Monitoria fetal continua, si aplica.
- ☐ Drenaje del foco séptico tan pronto sea posible. Garantizarestabilidad hemodinámica

ELECCIÓN ANTIBIÓTICOTERAPIA:

- Empírica y de amplio espectro
- Guiada por gérmenes más comunes
- Guiada por la severidad del cuadro
- Tener en cuenta los patrones de resistencia.

SEGUIMIENTO ANTIBIÓTICO

- Evaluación diaria del tratamiento antibiótico para decidir si cambiar o desescalonar

NOREPINEFRINA

Diluir 4 ampollas (total 16 mg) en 250 ml de DAD 5%

- Dosis 0.01 a 3 mcg/kg/min

Titular según metas de tensión arterial

Medición del lactato como indicador de respuesta a la resucitación inicial.

E

- ☐ Evaluación fetal. Definir finalización del embarazo solo bajo estricta indicación obstétrica

Intervenciones

- Drenaje del foco séptico emergente: tan pronto como sea medicamente y logisticamente posible
- Nutrición enteral temprana (primeras 72 horas)
- Prevención de:
  - Úlceras por estres
  - Neumonía asociada a ventilador
  - Otras infecciones
  - Úlceras por presión
  - Desacondicionamiento físico

Prevención de eventos trombóticos

- Tromboprofilaxis mecánica o como alternativa
- Tromboprofilaxis farmacológica
  - Heparinas de bajo peso molecular.

Seguimiento

Uso de variables dinámicas para guiar la reanimación

Metas de manejo

- TAM ≥ 65 mmHg
- Sensorio normal
- Llenado capilar < 3 segundos
- Diuresis ≥ 0,5cc/kg/h
- Lactato < 2 mmol/L
- Saturación arterial 02 >95%
- Saturación venosa de 02 >65%
- Glicemia 144-180 mg/dL
- EVA<4
- Normotermia

Si el paciente se encuentra en ventilación mecánica entonces:

- PaO2 >70 mmHg
- PaCO2 28-45 mmHg
- PaO2/FiO2 >300

Se recomienda un programa de transición para pacientes y familiares

Plan de seguimiento y rehabilitación interdisciplinario e integral

PASV

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO SEPSIS MATERNA

HOSPITAL FABRISO

Nombre_____**Identificación**_____**Edad**_____

Hospital_____**Ciudad**_____**Departamento**_____

Figura 1.

Sistema de alerta temprana obstétrica modificada MEOWS

Parámetros	3	2	1	0	1	2	3
PAS	<80	80-90		90-139	140-149	150-159	≥160
PAD				<90	90-99	100-109	≥110
FR/min	<10			10-17	18-24	25-29	≥30
FC/min	<60			60-110		111-149	≥150
% 02 para sat02> 95%				Aire	24 a 39%		≥40%
Temp °C	<34		34-35	35.1 37.9	38-38.9		≥39
Estado de conciencia				Alerta			No alerta

Puntuación 1-3 (suma)
Riesgo bajo, observación cada 4 horas, llamado a enfermera

Puntuación 3 o 4 (suma)
Riesgo intermedio, observación cada hora, llamado urgente al equipo de respuesta rápida

Puntuación ≥6 suma)
RIESGO ALTO, monitoreo continuo de signos vitales, llamado urgente al equipo de respuesta rápida

Figura 2.

SOFA SCORE SEPSIS

El parámetro más alterado es el indicador más sensible

0	1	2	3	4
Sistema Cardiovascular (Tensión arterial y uso de catecolaminas en ug/kg/min)				
Sin hipotensión	<70 mmHg	Dopamina < 5 o Dobutamina a cualquier dosis	Dopamina 5.1- 15 o Epinefrina ≤ 0,1 o Norepinefrina ≤0.1	Dopamina > 15 o Epinefrina ≤ 0,1 o Norepinefrina ≤0.1
Sistema Nervioso Cental (Puntuación Escala de Glasgow)				
15	13-14	10-12	6-9	<6
Sistema Respiratorio Pa02/Fi02				
≥400	<400	<300	<200 con soporte ventilatorio	<100 con soporte ventilatorio
Coagulación (conteo de plaquetas)				
≥150.000	<150.000	<100.000	<50.000	<20.000
Función hepática (bilirrubinas mg/dL)				
<1.2	1.2- 1.9	2.0-5.9	6.0-11.9	>12
Función renal (creatinina mg/dL)				
<1.2	1.2 - 1.9	2.0-3.4	3.5-4.9	>5.0

La puntuación total es la suma del parametro más alterado por sistema: Predictor de mortalidad

Puntuación por sistema:

- Mayor o igual a 2 indica disfunción orgánica,
- Mayor o igual a 4 indica falla orgánica

PASV

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO HEMORRAGIA POSTPARTO (HPP)

PQSV

Nombre_____**Identificación**_____**Edad**_____

Hospital_____**Ciudad**_____**Departamento**_____

Reconocimiento temprano HPP

☐ **Identificar y anunciar:** sangrado acumulado_____cc Hora inicio sangrado_____

ACTIVAR CÓDIGO ROJO OBSTÉTRICO PEDIR AYUDA

Signos vitales al momento de activar código rojo

- Frecuencia cardiaca _____ / Tensión arterial sistólica_____
- Índice de choque valor inicial _____
- Índice de choque a los 15 min_____
- Índice de choque a los 30 min_____

☐ Activar código rojo obstétrico, traer carro rojo.
☐ Desginar al Líder del equipo
☐ Designar una función a cada integrante del equipo
☐ Asegurar barandas de la cama
☐ Monitoría no invasiva de signos vitales cada 2 minutos

Identificar etapa de la HPP

HPP ETAPA 1

Sangrado 500-1000cc, Indice de choque <0.9
Tiempo de sangrado <10 minutos

A

☐ Asegurar vía aérea y monitorizar la tensión arterial y los signos vitales cada 2 minutos

B

☐ Administrar sumplemento de oxígeno con mascarilla con reservorio a 10 lt/min para asegurar la saturación de oígeno >95%

C

☐ Asegurar dos accesos venosos 16G o 18G y tomar muestras para laboratorio

☐ Administrar 500 cc de cristaloides (precalentar 30 segundos en microondas)

☐ Iniciar tratamiento farmacológico

1. **Oxitocina:** 40 unidades en 500 cc de solución salina a 60 cc/hora por bomba de infusión

Hora de inicio_____

2. **Metilergonovina:** 0.2 mg IM cada 20 minutos las primeras dos dosis y luego cada 4 horas. Máximo 5 dosis

1 dosis_____ 2 dosis_____

3. **Misoprostol:** 800 mcg sublingual o - 800 mcg intrarectal

Hora de administración_____

4. **Ácido tranexámico:** 1 gramo intravenoso en infusión rápida

1 dosis_____ 2 dosis _____

D

☐ Diagnóstico diferencial: causas de la HPP, piense y trate las causas

1. Tono: atonía uterina
2. Trauma: cervical, vaginal o uterino
3. Tejido: retención placentaria
4. Trombina: coagulopatía o deficiencias

E

☐ Exposición: evitar hipotermia

HPP ETAPA 2

Sangrado 1000-1500 cc- Índice de choque 0.9-1.4
Tiempo de sangrado 10-20 minutos

REPETIR ABCDE (descrito en etapa 1)

☐ Colocar traje antichoque (TANN)
☐ Colocar Balón intrauterino
☐ Hora de colocación_____ Insuflación _____cc
☐ Taponamiento vaginal con compresas estériles, si se coloca el balón intrauterino
☐ Realizar Test de taponamiento. Alertar al equipo si el sangrado es >200cc en 10 min
☐ Llamar a segundo Ginecólogo. Nombre_____
☐ Definir si se requiere una cirugía hemostática B-Lynch
☐ Solicitar gases arteriales, ácido láctico y fibrinógeno
☐ Avisar al equipo quirúrgico- Alertar sala de cirugía
☐ Control de hipotermia (mantas térmicas, líquidos endovenosos calientes)
☐ Administrar segundo bolo de cristaloudes (500cc) si la TAS< 90 y/o TAM < 60 mmHg
☐ Informar al familiar sobre la situación clínica y los pasos a seguir

Medicamentos

☐ Administrar medicamentos de Etapa 1.
☐ Iniciar cubrimiento antibiótico
☐ Adicionar segunda dosis de Metilergonovina 0.2 mg intramusculares
Adminisitrar segunda dosis de ácido tranexámico 1 gramo intravenoso

Adminisitrar dosis única de antibiótico

- Ampicilina Sulbactam 3 gramos IV , o alternativa:
- Ceftriaxona 2 gramos IV + Metronidazol 500 mg

Banco de sangre

☐ Preparar al paciente y al equipo para transfundir las unidades de glóbulos rojos
☐ Solicitar y transfundir 2 unidades de góbulos rojos

Acciones para controlar HPP

- Desgarro vaginal: realiace sutura
- Desgarro complejo: empaquetamiento y embolización
  - Solicitar apoyo de radiología intervencionista
- Restos placentarios: complete revisión de cavidad de forma manual
  - Decida si es necesario realizar curetaje
- Atonía de segmento uterino: Complete la colocación del Balón de Bakri
- Inversión uterina: reestablezca su posición, si es necesario use anestesia general
- Colapso materno ==> embolismo de líquido amniótico
  - Asegure la vía aérea y uso agresivo y temprano de vasopresores

HOSPITAL PADRINO

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LISTA DE CHEQUEO HEMORRAGIA POSTPARTO (HPP)

PASV

Nombre_____ **Identificación**_____ **Edad**_____

Hospital_____ **Ciudad**_____ **Departamento**_____

HPP ETAPA 3

Sangrado <1500 cc, índice de choque > 1.5
Tiempo de sangrado mayor a 20 minutos

REPETIR ABCDE (descrito en etapa 1)

- ☐ Preparar al paciente y al equipo para iniciar protocolo de
- ☐ transfusión masiva
- ☐ Iniciar protocolo de transfusión masiva
- ☐ Continuar con medicamento uterotónicos
- ☐ Avisar al equipo quirúrgico- Alertar y preparar quirofano
- ☐ Decidir procedimiento quirúrgico; histerectomía - cirugía de control de daños
- ☐ Solicitar gases arteriales, ácido láctico y fibrinógeno
- ☐ Avisar al equipo médico. Cirugía general, UCI
- ☐ Desarrollar un plan
- ☐ Comunicar al equipo médico y a la familia de la paciente-

PROTOCOLO DE TRANSFUSIÓN MASIVA

- 3 Unidades de glóbulos rojos
- 2 Unidades de plasma
- 8 Unidades de crioprecipitado

☐ **Medicamentos**

Continuar administrando medicamentos de etapa 1 y 2

☐ **Acciones**

Lograr hemostasia, intervención basada en la etiología de la HPP

☐ **Banco de sangre**

Solicitar 3 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma y 8 de crioprecipitado

- Si Fibrinógeno < 200 iniciar reposición con 8 unidades de crioprecipitado o inciar reposición con 3 gramos de concentrado de fibrinógeno
- Si el sangrado es activo y las plaquetas < 50.000, iniciar transfusión 1 aféresis plaqueta

HPP ETAPA 4

Colpaso cardiovascular con choque hipovolémico profundo y coagulopatía

- ☐ ACTIVAR CÓDIGO AZUL
- ☐ Reanimación CABD
- ☐ Iniciar bolos de cristalpides 500 cc
- ☐ Iniciar paquetes de transfusión masiva descritos en etapa 3
- ☐ Avisar al equipo quirúrgico- Alertar y preparar quirófano
- ☐ Decidir procedimiento quirúrgico: Histerectomía, cirugía de control de daños
- ☐ Avisar al equipo médico- Cirugía general, UCI
- ☐ Manejo en Unidad de Cuidados Intensivos

Medicamentos

☐ Reanimación hemostática avanzada

Acciones

☐ Lograr revertir el colapso cardiovascular, intervención basada en la etiología

HOSPITAL PADRINO

Diagnóstico del choque hipovolémico

El parámetro más alterado es el indicador más sensible

Perdida de volumen (%) y ml para una mujer entre 50-70Kg	Sensorio	Perfusión	Pulso	Presión Arterial sistólica (mm/Hg)	Grado del choque	Trasfusión
10-15% 500-1000 mL	Normal	Normal	60-90	>90	Compensado	Usualmente no requerida
16-25% 1000-1500 mL	Normal y/o agitada	Palidez, frialdad	91-100	80-90	Leve	Posible
26-35% 1500-2000 mL	Agitada	Palidez, frialdad, más sudoración	101-120	70-79	Moderado	Usualmente requerida
>35% >2000mL	Letárgica o inconciente	Palidez, frialdad, más sudoración y llenado capilar > 3segundos	>120	<70	Severo	Transfusión Masiva probable

Tiempo (minutos)

- **5'** Diagnóstico
- **10'** Manejo médico
- **15'** Colocación TANN
- **20'** Colocación del balón
- **30'** Definir respuesta